Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria

Rua Alameda Buenos Aires, 201 - Bairro: Nossa Senhora das Dores - CEP: 97050545 - Fone: (55) 3222-8888 - Email: frsantmari1vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5036827-76.2023.8.21.0027/RS

AUTOR: SILVINO SANTIN

RÉU: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

Vistos e examinados os autos.

SILVINO SANTIN, já qualificado, ajuizou ***Ação ordinária de medicamentos/fornecimento de insumos, com pedido de tutela de urgência*** em face do **IPÊ-SAÚDE-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL**, também qualificado, alegando, em síntese que, é acometido de câncer tipo Linfoma não Hodgkin, patologia classificada pelo CID C85.7, a qual se manifesta de forma severa no demandante desde o ano de 2021. Mencionou que devido a progressão da doença foi prescrita a realização do tratamento com o medicamento Ibrutinibe 140mg, 03 cápsulas ao dia. Informou ter solicitado o fármaco ao plano fde saúde réu, mas foi indeferido. Discorreu sobre o direito à saúde. Colacionou entendimentos jurisprudenciais para amparar o pedido. Pleiteou a concessão da tutela de urgência. Requereu a procedência da ação. Vindicou a concessão da gratuidade judiciária. Anexou documentos (evento 1, INIC1).

Recebida a inicial, foi indeferida a concessão da gratuidade judiciária e deferido o pagamento das custas processuais de forma parcelada (evento 11, DESPADEC1).

Em decisão, foi concedida a tutela de urgência pleiteada na exordial (evento 22, DESPADEC1).

Citado, o Instituto de Assistência à Saúde apresentou contestação (evento 32, CONT1), arguindo o medicamento postulados não estão previstos no Protocolo Oncológico adotado pelo IPE Saúde para o tratamento da enfermidade apresentada. Referiu que o IPE Saúde é um plano de natureza pública, adstrito à regulamentação administrativa; e, embora não esteja sujeito a normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Mencionou que o Poder Judiciário ao o interferir nas regras estabelecidas pelo administrador em plano de saúde restrito aos seus servidores estaduais, abala os princípios da igualdade, da legalidade e da independência e harmonia dos poderes previstos pela Carta Magna. Aduziu que assistência à saúde prestada pelo IPE Saúde foi reorganizado pela Lei Complementar nº 15.145/2018. Defendeu que diferentemente dos Planos de Saúde privados que possuem contratos com seus beneficiários e necessitam de cláusula contratual expressa para a negativa de cobertura, o IPE-Saúde é instituído por Lei e administrado por uma Autarquia estadual, o que determina a observação integral dos princípios aplicáveis à Administração Pública. Teceu considerações sobre a alternativa para tratamento de LINFOMA DE HODGKINS dentro da cobertura do IPE Saúde. Discorreu sobre a sustentabilidade do fundo de assistência à saúde-FAS. Requereu a improcedência do pedido.

Houve réplica (evento 35, RÉPLICA1).

Intimadas, as partes não manifestaram interesse na produção de outras provas (evento 44, PET1 e evento 45, PET1).

O Ministério Público, em promoção, opinou pela procedência do pedido (evento 50, PROMOÇÃO1).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a fundamentar.

Inicialmente, tratando-se de questão unicamente de direito, desnecessária a produção de provas em audiência, sendo possível o julgamento antecipado do feito, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito.

A parte autora afirma na inicial que possui Linfoma não Hodgkin, patologia classificada pelo CID C85.7, necessitando realizar o tratamento médico com a utilização do medicamento Ibrutinibe 140mg, 03 cápsulas ao dia.

O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul - IPÊ-SAÚDE, por sua vez, arguiu que o tratamento postulado não se encontra coberto pelo plano, bem como não estão previstos no Protocolo do Instituto.

Inicialmente, cabe salientar que o artigo 4º da Lei Complementar nº 15.145/2018, que dispõe sobre o IPÊ-Saúde, refere que integram o plano de saúde atendimento médico, hospitalar, atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, assim como ações de prevenção da doença e promoção à saúde: *(...) Artigo 4º- O Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPE Saúde – consiste na cobertura das despesas decorrentes dos*

procedimentos previstos em tabelas próprias do Instituto para atendimento médico, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, bem como dos atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários, na forma estabelecida nesta Lei Complementar e em resoluções do Órgão Gestor. (...)

Todavia, o parágrafo único do artigo 4º da citada Lei Complementar restringe o fornecimento de tratamentos, exames, procedimentos, insumos e materiais aos que estejam previsto nas tabelas do Instituto.

Insta frisar que, em que pese exista a previsão de exclusão na legislação de regência, somente justifica-se a sua incidência quando não comprovada a necessidade do fornecimento dos tratamentos, exames, procedimentos, insumos e materiais para o tratamento da patologia de que está acometido o segurado, conforme entendimento sedimentado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

> *"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPÊ- SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE CÂNCER JAKAVI® (RUXOLITINIBE). PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC.* ***A circunstância de não existir previsão de cobertura no regulamento do IPERGS não é motivo suficiente para o indeferimento do pedido. Conforme dispõe o art. 4º da Lei Complementar 15.145/08, integram o Plano IPE-SAÚDE os atendimentos médicos, hospitalares, ambulatoriais, laboratoriais, bem como atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários.*** *Em que pese as disposições do parágrafo primeiro do artigo supramencionado, tem-se que a ausência de previsão no Protocolo Oncológico não deve servir de obstáculo ao fornecimento do tratamento médico postulado, notadamente porque as Recomendações são de 2010, logo desarrazoado negar acesso do segurado a tratamento médico quando evidente a ausência de atualização do Protocolo e suas Recomendações em Oncologia. Hipótese dos autos em que se encontram presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação de tutela requerida, uma vez que restou comprovada a necessidade e a urgência do medicamento solicitado, através de laudo médico especializado, razão pela qual imperiosa a manutenção da tutela provisória de urgência concedida na origem. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70079951091, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 27/02/2019)" [grifo nosso]*
>
> *"APELAÇÃO CÍVEL. IPÊ-SAÚDE. LINFOMA NÃO-HODGKIN. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. IBRUTINIBE. NEGATIVA DO IPERGS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO.* ***I. A Lei nº 12.134/2004, que reestruturou o IPERGS, dispõe que o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, seus dependentes e pensionistas, engloba um conjunto de ações visando à prevenção de doenças, à promoção, educação e assistência à saúde de seus usuários (arts. 1º e 2º). II. Em que pese a edição da Lei Complementar nº 15.145/2018, que altera a Lei Complementar nº 12.066/2004, disciplinando que descabe a imposição ao IPERGS de medicamentos não previstos em seus regramentos, entendo que a falta de previsão nos protocolos ou listas da autarquia previdenciária e o alto custo do medicamento não devem servir de obstáculo ao fornecimento do tratamento postulado, visto que demonstrada a necessidade do uso do fármaco, bem como a condição de segurado da autarquia.*** *III. Honorários advocatícios reduzidos. Apelo parcialmente provido. (Apelação Cível Nº 70080627953, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 27/03/2019)"*

Ademais, cumpre esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça vem firmando entendimento de que não cabe ao plano de saúde selecionar o tratamento que será dispensado ao segurado para a patologia coberta pelo plano, como ilustram as seguintes ementas de julgados proferidos pelo Tribunal da Cidadania:

> *"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de obrigação de fazer combinada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.* ***3. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. O fato do procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, tendo em vista que se trata de rol meramente exemplificativo.*** *4. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno no recurso especial desprovido. (AgInt no AREsp 1345913/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 27/02/2019)" [grifo nosso]*
>
> *"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de obrigação de fazer combinada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.* ***3. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. O fato do procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, tendo em vista que se trata de rol meramente exemplificativo.*** *4. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno no recurso especial desprovido. (AgInt no AREsp 1345913/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 27/02/2019)" [grifo nosso]*

Dessa forma, extrai-se dever do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul - IPÊ-SAÚDE em fornecer o tratamento postulado pela parte autora, mesmo que este não esteja coberto pelo plano ou que não esteja previsto no Protocolo do Instituto, desde que comprovada a sua necessidade.

No presente caso, os documentos trazidos aos autos confortam a pretensão.

Consoante o relatório médico assinado pelo médico Juarez Chiesa ressaltou a necessidade da realização do tratamanto médico com o fármaco indicado na inicial, tendo em vista a possibilidade de invasão medular, conforme colaciono o referido laudo (evento 1, LAUDO7):

RELATÓRIO MÉDICO

Silvino Santin, 86 anos, masculino, branco, casado, Professor Universitário aposentado, procedente de Santa Maria, com diagnóstico de Linfoma não Hodgkin, tipo de Células do Manto – CID: C85.7 em 2021.

Na ocasião foi tratado com o regime R-CHOP por 6 (seis) ciclos, com boa resposta.

Em Agosto de 2023, apresentou sinais de progressão de doença, sendo levado a biópsia de linfonodo que confirmou doença em atividade.

Foi solicitado, via sistema do IPERGS, tratamento de segunda linha, porém sem a possibilidade de análise pelo sistema on-line. Devolvido como negado.

Foi tentado encaminhar documentação por e-mail, porém sem uma resposta adequada. Ao que parece não há a vontade de oferecer tratamento ao paciente.

Em virtude acima exposto forneço o presente Relatório, a pedido da familiar, para tentar obter de outra forma a droga em questão ou que o IPERGS se manifeste sobre regime que possa ser disponibilizado.

Ressalto que por ter já recebido Doxorrubicina, a referida droga não mais pode ser utilizada. Pelo quadro clínico, *opto pelo uso de Ibrutinibe*, conforme receita em anexo. A referida droga está em uso no Brasil, aprovada pela ANVISA, recomendada por muitas Sociedades de Hematologia/Oncologia no mundo.

Solicito inicialmente, dose para 6 (seis) meses, conforme receita em anexo.

Necessita o Tratamento, com URGÊNCIA, visto que apresenta doença com avançada invasão medular.

Ao dispor para esclarecimentos.

Santa Maria, 26 de Outubro de 2023

Juarez Chiesa-CREMERS 17488
Médico.

Portanto, diante do laudo médico juntado pela parte autora, aliado às informações mencionadas durante o trancorre do feito, resta evidente a necessidade da autora em realizar o tratamento com os **medicamentos** postulados, para tratamento da patologia que lhe acomete.

Registro que a condição de segurado da autora, demonstrada pelo documento do evento 1, COMP6, restou incontroversa nos autos.

Consigno que mesmo demonstrada a necessidade do tratamento pela parte autora, restou indeferido em sede administrativa o fornecimento dos **medicamentos** postulados na exordial (evento 1, RESPOSTA10).

No entanto, como já exposto, embora não previstos *"nas recomendações técnicas de oncologia do IPÊ-SAÚDE"*, tal circunstância não é suficiente para elidir a responsabilidade da Autarquia ré em fornecer o tratamento adequado para a patologia da demandante.

Dispositivo

Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado por **SILVINO SANTIN**, em face do **INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL-IPÊ-SAÚDE** para determinar que o réu **forneça o medicamento** Ibrutinibe 140mg, 03 cápsulas ao dia, conforme laudo médico, sob pena de bloqueio de valores, nos termos do artigo 497, inciso I, do Código de Processo Civil.

Confirmo a tutela de urgência deferida no evento 22, DESPADEC1.

Isento o IPÊ-SAUDE quanto ao pagamento da taxa única, nos termos do art. 5º da Lei Estadual nº 14.634/2014, bem como das despesas de condução de Oficial de Justiça, exceto a título de desembolso. Deverá adimplir apenas as demais despesas processuais.

Outrossim, condeno o IPÊ-SAUDE ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte autora, os quais fixo em R$ 600,00, conforme dispõe o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Havendo apelação, considerando as novas disposições do Novo Código de Processo Civil (art. 1.010), que determina a remessa do recurso independentemente de juízo de admissibilidade no primeiro grau, deverá o Cartório intimar a parte recorrida para oferecer contrarrazões e dar vista ao Ministério Público para parecer, se for o caso, e, na sequência, remeter os autos à instância superior.

Tratando-se de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, deve ser submetida ao reexame necessário, consoante entendimento cristalizado na Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, com ou sem recurso voluntário, remetam-se os autos ao Colendo Tribunal de Justiça para reexame.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Documento assinado eletronicamente por **DIEGO TEIXEIRA DELABARY, Juiz de Direito**, em 27/02/2025, às 13:37:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10077694541v5** e o código CRC **170e92ec**.